



PATIENTENDATEN

Patient	Keller, Thomas	Geburtsdatum	08.12.1955 (68 Jahre)
Adresse	Bahnhofstrasse 23, 8001 Zürich, Kanton Zürich	AHV-Nummer	756.1234.5678.90
Krankenkasse	Helsana AG — Vers.-Nr. CH-ZH-2024-881204	Behandelnder Arzt	Dr. med. Eva Zimmermann, Neurologie FMH
Falldatum	23.09.2024 (Ambulante Sprechstunde)	Patientennummer	USZ-2024-N-078834

1 — KONSULTATIONSGRUND UND AKTUELLE SYMPTOMATIK

Herr Keller stellt sich auf Zuweisung seines Hausarztes vor wegen progredienter kognitiver Verschlechterung seit ca. 12–18 Monaten. Ehefrau berichtet über zunehmendes Vergessen von alltäglichen Aufgaben, Orientierungsschwierigkeiten in vertrauter Umgebung, Wortfindungsstörungen sowie Wesensveränderungen (Reizbarkeit, sozialer Rückzug). Zudem besteht ein kleinschrittiges, breitbasiges Gangbild seit etwa 6 Monaten sowie Dranginkontinenz. Kein Tremor in Ruhe. Keine Sturzanamnese. Vorerkrankungen: arterielle Hypertonie seit 2008, Hyperlipidämie, Status nach transitorischer ischämischer Attacke (TIA) 2020 (keine Residuen). Alkohol: ca. 1–2 Gläser Wein täglich. Keine Familienanamnese für Demenz.

2 — NEUROLOGISCHER STATUS UND KOGNITIVTESTS

Test / Befund	Ergebnis	Norm / Referenz
MMST (Mini-Mental-Status)	21 / 30 Punkte	≥ 27 Punkte (normal)
MoCA	17 / 30 Punkte	≥ 26 Punkte (normal)
Uhrentest	Erheblich gestört	Korrekt
Gangbild	Kleinschrittig, breitbasig, Retropulsion	Unauffällig
Riechtest (UPSIT)	28 / 40	≥ 35 (normal für Alter)
Blutdruck (liegend/stehend)	152/88 / 148/84 mmHg	< 130/80 mmHg
Schluckfunktion	Unauffällig	Normal
Reflexe	BSR + bilateral (symmetrisch)	Normal

Vaskuläre Risikofaktoren: Hypertonie (unzureichend eingestellt), Dyslipidämie, Status nach TIA. MRT Schädel (3T, 23.09.2024): Ausgeprägte Mikroangiopathie bds. (Fazekas III), Hippokampusatrophie bds. (MTA-Score 2,5), periaquäduktale Gliose, dilatierte innere und äussere Liquorräume, kein frisches Ischämieareal, kein Raumforderungszeichen. EEG: Leichte Allgemeinveränderung, kein Anfallsmuster. Liquorpunktion (22.09.): Albumin 48 mg/L, A-beta42 592 pg/mL (↓), Tau 689 pg/mL (↑), p-Tau181 84 pg/mL (↑) — Biomarkerprofil vereinbar mit Alzheimer-Pathologie.

3 — DIFFERENTIALDIAGNOSEN

Wahrscheinlichste DD:

Gemischte Demenz (Alzheimer-Erkrankung + vaskuläre Komponente) — MRT-Befund, Liquorbiomarker und klinisches Bild sprechen für kombinierte Pathologie.

Zweite DD:

Normaldruck-Hydrozephalus (NPH) — klassische Trias (Gangstörung, Demenz, Inkontinenz) vorhanden; MRT zeigt jedoch auch Atrophie.

Dritte DD:

Lewy-Körper-Demenz — weniger wahrscheinlich bei fehlendem Tremor und stabiler Kognition ohne Fluktuationen.

Auszuschliessen:

Schilddrüsenerkrankung (TSH normal), Vitamin-B12-Mangel (B12 288 pg/mL), Depression (GDS 7/15 — leicht).

4 — EMPFEHLUNGEN UND WEITERES VORGEHEN

Neuropsychologische Testbatterie (vollständig) zur Charakterisierung des Demenzprofils. Lumbalpunktion mit grossvolumigem Ablassversuch (Tap-Test) zur Beurteilung einer NPH-Komponente. Antihypertensive Therapie intensivieren (Zielwert < 130/80 mmHg). Vorstellung in der Gedächtnisambulanz (Memory Clinic USZ). Fahreignung: vorläufige Empfehlung, das Führen eines Fahrzeuges auszusetzen. Angehörigenberatung geplant.

△ SYNTHETIC DOCUMENT — All patient data, names, identification numbers and clinical details in this document are entirely fictional and have been generated for AI research purposes. Any resemblance to real persons is purely coincidental. Not for clinical use.